

Mordeduras y su Manejo General

- Dentro de las lesiones causadas por animales, es imperativo establecer protocolos profilácticos infecciosos debido al inmenso microbioma inyectado en el trauma.
- **Causas Frecuentes:**
 - 1. Perros.
 - 2. Gatos (principal peligro para lactantes sin supervisión o en cunas).
 - 3. Humanos (incluso las incrustaciones dentales producto de golpes de puño en la boca se manejan infectológicamente bajo el mismo axioma).

Esquema de Acción

1. **Lavado local domiciliario pre-hospitalario:** Profilaxis más determinante, consiste en lavado exhaustivo en la casa con abundante agua y jabón. 2. **Aseo médico:** Irrigación a presión en el Box de Urgencias con Suero Fisiológico. 3. **Vacunación Antitetánica:** Acorde al esquema protocolar clásico para todas las disrupciones de piel. 4. **Profilaxis de Antibióticos:** A diferencia del tétanos, los antibióticos **NO** se prescriben universalmente. Cuando están indicados, el fármaco de rigor absoluto es **Amoxicilina + Ácido Clavulánico** (para combatir al de base *S. aureus* sumado a las patológicas orales como *Pasteurella multocida* u *Eikenella corrodens*). **Indicaciones de Amoxi/Clav:** - Todas las mordeduras de **gato** (el 70% se infecta, los dientes finos inoculan en profundidad). - Todas las mordeduras de **humano**. - Heridas masivas (ej. destrozos por perros de raza grande). - Mordeduras comprometedoras en huesos o articulaciones (ej. Todas las que ocurren en las **manos**, para prevenir osteomielitis/artritis séptica). - Obviada diagnóstica: Toda lesión que llega ya francamente infectada días posteriores. 5. **Sutura:** Como ley universal, **NO** se suturan las zonas porque concentran nichos sucios. La incisión principal se cierra operativamente sólo si genera colgajos extremadamente inmensos posterior a un lavado en pabellón quirúrgico (Aseo quirúrgico estricto).

Indicaciones Actuales de Vacuna Antirrábica

(Importante: No ostenta ninguna contraindicación; se vacuna indistintamente bajo sospecha aunque la paciente esté embarazada o inmunodeprimida, puesto que la hidrofobia tiene 100% de letalidad).

- **Vínculo o Contacto con Murciélagos:** Despertar con el animal volador en el dormitorio (aunque no haya marca de picadura detectada), infante jugando con murciélago muerto o explorar lugares crónicamente infestados.
- **Animal NO Observable:** Ataque y fuga en vía pública, perro/gato que no se logra seguir por al menos 10 días, sin importar la provocación.
- **Animal con Clínica Compatible:** Manifestaciones confusas neurológicas de rabia (parálisis bucal, babeo, incapacidad de tragar, conducta enloquecida, o muerte repentina del vector).
- **Zoonosis Salvaje Rara:** Zorrillo, zorro, león marino, lémur, hámsters salvajes o quirópteros no nativos.

Quemaduras

Las etiologías se ordenan en prevalencia con los incendios/fuego en la cúspide global.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En **Pediatría** la regla epidemiológica cruda se invierte drásticamente: El escaldamiento o contacto con **Líquidos Calientes** encabeza lejos las quemaduras en recién nacidos, lactantes preescolares (uso irresponsable de agua de teteras, sartenes, sopas hirviendo, andadores por cocina).

Enfrentamiento y Soporte Inicial

El Gran Quemado se enfrenta universalmente bajo los lineamientos del paciente poli-trauma y el **A-B-C: - B y C (Reanimación Hidroelectrolítica)**: Los cristaloides de volemia generosa intravenosa determinan el control del principal obituario en la etapa aguda: **El Shock Hipovolémico masivo** inducido por las enormes pérdidas hacia un gran "tercer espacio". - **Analgesia Agresiva:** Requieren esquemas combinados fuertes; AINEs, Opioides plenos y bloqueos si se justifica, previniendo trauma del dolor extremo. - **Antibióticos: NO SE DEJAN DE FORMA PREVENTIVA.** El uso abusivo no previene la evolución y encarece la resistencia. Solo se ocupan como esquema terapéutico en una quemadura francamente infectada transcurridos los días.

Clasificación Biológica de Profundidad

TABLA 1.7.1: GRADO DE COMPROMISO VS CLÍNICA E INSPECCIÓN		
GRADO DE COMPROMISO	CLÍNICA E INSPECCIÓN	SENSIBILIDAD (DOLOR)
Tipo A (Epidérmica Superficial)	Roja radiante ("quemadura de sol").	Altamente Dolorosa e hipersensibilizada.
Tipo AB (Dérmica Intermedia)	Rosada plástica desvitalizada. Depende de folículos.	Dolor moderado intermitente difuso.
Tipo B (Espesor y Transmural Total)	Placa seca Blanca (aspecto cuero o cartón) o Negra (carbonizada). Escara asfíctica.	INDOLORA, pérdida nerviosa absoluta irremediable (Gran factor diagnóstico al punzar).

(Nota: Las flictenas reactivas deben drenarse y eliminarse al superar el umbral del nivel superficial A para permitir una apropiada inspección posterior de las AB y B).

Cuidados Especiales Topográficos y Evolutivos

- **Región Facial:** Presenta inmenso riesgo de aspiración, irritación química pulmonar y edema agudo de glotis si se inhalaron gases ardientes asfixiantes. **Indicación precoz cardinal:** Prevención con **Intubación Endotraqueal de Urgencia** si hay rastros de hollín intrabucal, pelos nasales chamuscados, disfonía o expectoración oscura.
- **Exposición Abierta Constante:** Las lesiones de la cara y del **periné** son la gran excepción curatoria; **NO se colocan apósitos sobre ellas nunca**, sino que ventilan descubiertas.
- **Quemaduras Circulares en Extremidades:** Amenazan velozmente con comprimir como un anillo fibrótico el paquete vasculo-nervioso induciendo isquemia distal letal (**Síndrome Compartimental**). Requieren inmediata **Escarectomía/Fasciotomía Longitudinal**.
- **Extremidades (Manos / Dedos):** Su curación debe llevarse a cabo posicionando vendajes separadores en las bases inter-digitales, evitando que la regeneración funda los apéndices.

EUNACOM CRITERIOS

Quemadura Eléctrica: Es un engaño dermatológico (*fenómeno del Iceberg*). La piel resiste el paso de alta tensión pero incinera al músculo profundo en la trayectoria. - **Evolución:** Altamente traicionera y empeora a los días, estricta hospitalización siempre. - **Monitoreo:** **Electrocardiograma ECG base obligatorio** ante riesgo inminente crónico de taquiarritmias ventriculares fulminantes. - **Peligro Secundario:** Necrosis tisular masiva suelta de Mioglobina renal (Rabdomiolisis), resultando en mortífera **Insuficiencia Renal Aguda mioglobinúrica**. Debes vigilar mediante Niveles de **Creatin-Fosfo-Kinasa (CK)** e infundir líquidos abundantes emparejados con **Bicarbonato Endovenoso Urinario** para arrastrar los tóxicos necróticos.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un niño de tres años es llevado a urgencias con una mordedura de gato en el antebrazo. La herida tiene un centímetro de profundidad, no hay eritema ni signos de infección. La madre dice que el gato vive en casa y fue vacunado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Mordeduras y Quemaduras. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El antibiótico de elección en mordeduras es amoxicilina con ácido clavulánico; se indica en mordedura de gato, humana, extensa, en manos, o infectada.
- La vacuna antirrábica se indica por contacto con murciélago, animal no observable, animal con síntomas de rabia, o mordedura por animal salvaje inusual.
- Las quemaduras grado A son rojas y muy dolorosas y curan solas en siete días; las grado B son blancas o negras e indoloras y siempre requieren cirugía.
- Las quemaduras grado AB tienen pronóstico incierto según sensibilidad, llene capilar y estado de folículos pilosos; pueden curar en catorce días o requerir cirugía.
- Los antibióticos profilácticos no están indicados en quemaduras; solo se usan cuando ya hay infección establecida.
- La regla del nueve divide el cuerpo en segmentos del nueve por ciento para calcular superficie quemada; la palma equivale al uno por ciento.
- Las quemaduras eléctricas se hospitalizan siempre por riesgo de rabdomiolisis y arritmia; requieren CK y ECG.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MORDEDURAS Y QUEMADURAS)**PREGUNTA 1**

Un niño de tres años es llevado a urgencias con una mordedura de gato en el antebrazo. La herida tiene un centímetro de profundidad, no hay eritema ni signos de infección. La madre dice que el gato vive en casa y fue vacunado. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Aseo con suero fisiológico, sin antibióticos ni vacuna antirrábica
- B)** Aseo con suero, amoxicilina con ácido clavulánico, vacuna antitetánica según esquema
- C)** Aseo, sutura inmediata, antibióticos y vacuna antirrábica
- D)** Solo aseo y observación sin antibióticos porque no hay infección
- E)** Aseo, antibióticos, sutura y vacuna antirrábica

PREGUNTA 2

Un paciente de treinta años llega a urgencias con quemaduras en el brazo derecho y el pecho. El brazo presenta piel blanca, insensible al tacto. El pecho está rojo y muy doloroso. ¿Cómo se clasifican estas quemaduras y cuál requiere cirugía?

- A)** Ambas son grado A, ninguna requiere cirugía
- B)** El brazo es grado B que requiere cirugía; el pecho es grado A que cura sola
- C)** Ambas son grado B y requieren cirugía urgente
- D)** El brazo es grado AB y puede curar sola; el pecho es grado B y requiere cirugía
- E)** El brazo es grado AB que requiere observación; el pecho es grado A sin tratamiento quirúrgico

PREGUNTA 3

Un electricista de cuarenta años sufre una quemadura eléctrica de alta tensión en el brazo. Al examen, la quemadura parece pequeña y superficial. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Alta con curaciones ambulatorias por ser quemadura pequeña
- B)** Hospitalización, CK seriada, ECG y monitorización
- C)** Antibióticos profilácticos y curaciones ambulatorias
- D)** Hospitalización solo si el paciente tiene síntomas de arritmia
- E)** Cirugía urgente para desbridar la quemadura

RESUMEN: MORDEDURAS Y QUEMADURAS

Las mordeduras se manejan con lavado inmediato con agua y jabón en casa, aseo con suero fisiológico en urgencias, vacuna antitetánica según esquema, vacuna antirrábica según indicaciones, antibióticos en casos seleccionados, y manejo de la herida. El antibiótico de elección es amoxicilina con ácido clavulánico. Las indicaciones de antibióticos son mordedura de gato, mordedura humana, herida muy extensa, mordedura en manos, o mordedura que ya se infectó. Las indicaciones de vacuna antirrábica incluyen contacto con murciélago, animal no observable, animal con síntomas de rabia, o mordedura por animal salvaje inusual. Las mordeduras no se suturan salvo que sean muy grandes. Las quemaduras se clasifican en grado A, superficial, roja y muy dolorosa; grado AB, intermedio, con pronóstico incierto que puede curar sola en catorce días o requerir cirugía; y grado B, de color blanco o negro, indolora por destrucción de nervios, que siempre requiere cirugía. El manejo inicial es ABC, hidratación con cristaloides, analgesia agresiva y vacuna antitetánica. No se dan antibióticos profilácticos. La regla del nueve divide el cuerpo en segmentos de nueve por ciento para calcular la superficie quemada. Indicaciones de cirugía: quemaduras grado B siempre, quemaduras grado AB que no evolucionan bien, quemaduras circulares en extremidades por riesgo de síndrome compartimental. Las quemaduras eléctricas siempre se hospitalizan, requieren CK para descartar rabdomiólisis y ECG por riesgo de arritmia.